EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS
N° EGRESO : 83278
SERVICIO : UTI HSC
FECHA : 2024-04-25 15:55:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: GUILLERMINA DEL C MENDOZA LABRA			**RUN**	: 4.348.139-8
F.Nac	: 10-01-1943	**Edad**	: 81 AÑOS, 3 MESES	**Género**	: Femenino
Dirección	: CAROL URZUA 226			**Comuna**	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	**Teléfono**	: 93721504		
Fecha Ingreso	: 2024-04-18	**Fecha Egreso**	: 2024-04-25 15:55:00	**Causal**	: MEDICA
Condición	: VIVO	**Destino**	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	**Derivación**	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. E83.5-TRASTORNO DEL METABOLISMO DEL CALCIO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. Hipercalcemia severa inducida por fármacos, resuelta
2. Tiroidectomía total, por Carcinoma papilar, variedad usual, con componente de células altas
- Hipoparatiroidismo post quirúrgico
- Hipotiroidismo post quirúrgico
3. FA cRVR, estabilizada
4. Hipokalemia corregida
5. Coagulopatia por TACO.
5. Antecedentes: Insuficiencia cardiaca, cardiopatía coronaria, FA persistente en TACO, Diabetes Mellitus tipo 2, HTA, ERC etapa 4

Procedimientos invasivos: Middline (18/04/24), Linea arterial (18/04/24)

<u>DIAGNÓSTICOS CIE10</u>

1. E83.5-TRASTORNO DEL METABOLISMO DEL CALCIO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. E89.2-HIPOPARATIROIDISMO CONSECUTIVO A PROCEDIMIENTOS (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. E89.0-HIPOTIROIDISMO CONSECUTIVO A PROCEDIMIENTOS (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
4. I48.2-FIBRILACION AURICULAR CRONICA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
5. E87.6-HIPOPOTASMIA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
6. D68-OTROS DEFECTOS DE LA COAGULACION (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
7. I50-INSUFICIENCIA CARDIACA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
8. E10.2-DIABETES MELLITUS INSULINO DEPENDIENTE CON COMPLICACIONES RE (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
9. I10-HIPERTENSION ESENCIAL(PRIMARIA) (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
10. N18.9-INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente con antecedentes descritos, consulta en servicio de urgencia HSC el 17/04/24 derivada desde extrasistema por hipercalcemia de 17 mg/dl, a su ingreso se controla con exámenes de laboratorio, destacando Ca 16 mg/dl. Evaluada por Residente UTI, se decide ingreso a unidad para manejo y corrección de hipercalcemia. A su ingreso paciente orientada en tiempo y espacio, se inicia manejo con volemizacion endovenosa + diuréticos endovenosos; en exámenes de ingreso destaca INR 5.28 por lo que se difiere tratamiento anticoagulante. En cuanto a su hemodinamia, paciente con crisis hipertensiva, por lo que se maneja con BIC de urapidil con ajustes posteriores de antihipertensivos orales. Se mantiene manejo de hipercalcemia con buena respuesta, con disminución paulatina del calcio en los controles diarios. El 20/04/24 durante la

noche, la paciente presenta desorientación temporoespacial que se logra contener verbalmente. Sin embargo, durante la mañana del 21/04/24 la paciente se presenta mas desorientada, con delirio hiperactivo, poco cooperadora, negándose a recibir tratamiento farmacológico considerando necesidad de urapidil SOS por alzas de PA asociado a la agitación. Debido a lo anterior, se intenta agitación verbal, sin respuesta, por lo que se indica contensión física. Durante la visita de familiares, paciente rechaza visita de acompañantes. Médico de turno conversa con familiar responsable, se explica situación y aclaran dudas ante presencia de hematomas en ambas extremidades superiores, secundarias a punciones arteriales y venosas, en contexto de anticoagulación con INR en rango sobreterapeutico. Control de INR 21/04/24 en 2.05, por lo que se indica acenocumarol 1 mg. Paciente se mantiene desorientada, logrando resolución de delirio entre 23 y 24 de abril. En lo relacionado a control de INR, el 23/04/24 se pesquisa valor 5.12 por lo que se indica administración de vitamina K ev. El 23/04/24 se alcanza resolución de hipercalcemia, calcio en rangos normales altos.
Se evalua posibilidad de uso de NACO sin embargo por antecedente de ERC, se difiere y mantiene indicacion de acenocuramol.
Actualmente paciente con hemodinamia estable, ventilando espontaneo sin requerimiento de FiO2 adicional, sin conflicto infeccioso ni renal, en tratamiento con insulina NPH, hipercalcemia resuelta, en proceso de reajuste de dosis de acenocumarol, delirio resuelto, por lo que se decide HODOM para reajuste de acenocumarol segun control de INR.

que consulta según refiere familiar por presentar cuadro arrastrado de varios días de evolución caracterizado por astenia, adinamia, debilidad generalizada, dolor abdominal intermitente, y cefalea, sin fiebre, hoy se toma controles de laboratorios para evaluación con nefrólogo donde se reporta hipercalcemia en 17, motivo por el cual acude a SU, se toma nuevamente control de Calcio ev reportándose en 16, en vista de cuadro se decide su ingreso para manejo en la unidad. Como antecedente, la paciente estuvo hospitalizada en marzo 2024 por Shock cardiogénico, detectándose hipocalcemia, por lo que al alta se indicó Calcio 2 comprimidos c/8h, calcitriol 1 comp c/12 h, con buena adherencia farmacológica. Ex Fisico: PA 213/105mmhg (141), Fc 66, Fr 20, Sat 91% FIO2 ambiental Vigil, OTE, letárgica Cuello móvil sin adenopatías, yugulares planas. Tórax simétrico, normoexpansible MP+ SRA, RR2t S/S Abdomen globoso a expensas de panículo adiposo, BDI, RsHsAs+. Extremidades sin edema sin signos de TVP Glasgow 15pts.

PLAN DE MANEJO:

HODOM Control INR + ELP para reajuste domingo 28/04/24, evaluar niveles de K sérico.
Control en 15 dias en Policlinico Anticoagulante (TACO)
Control en 15 días en CAE Endocrinología HSC

INDICACIONES AL ALTA

1. HODOM
2. Reposo relativo asistido
3. Regimen hiposódico diabético
4. Omeprazol 20 mg 1 comprimido al día vo
5. Levotiroxina 75 mcg en ayuna vo
6. Furosemida 40mg 1 comprimido al día vo
7. Carvedilol 25 mg 1/2 comprimido c/12 hrs vo
8. Hidralazina 50 mg 2 comprimidos cada 6 hrs vo
9. Amlodipino 10 mg 1 comprimido al dia vo
10. Metildopa 250 mg 1 comprimido c/12 hrs vo
11. Slow K 600 mg 1 comprimido c/8hrs vo
12. Lactulosa 10 cc c/8 hrs vo
13. Elcal D 1 comprimido c/8 hrs vo
14. Acenocumarol 4 mg 1/4 comprimido día por medio, próxima dosis sábado 27/04/24, luego según reajuste
15. Control INR + ELP para reajuste domingo 28/04/24, evaluar niveles de K sérico.
16. Sertralina 50 mg 1 comprimido por la mañana vo
17. Insulina NPH 18 UI am - 8 UI pm sc
18. Control en 15 dias en Policlinico Anticoagulante (TACO)
19. Control en 15 días en CAE Endocrinología HSC

EXÁMENES Y RESULTADOS

25/04/24: Ca c 9.6, Crea 1.8 ELP 138/3.5/110
24/04/24: Ca c 9.6, ELP 142/4/106
22/04/24: crea 1.6, calcio corregido 10.9, ELP 142/3.5/111, INR 1.61, resto normal
21/04/24: Crea 1.8, Alb 3.2, Calcio 10.2, Ca corregido 10.8, ELP 148/3.4/116, Uremia 59, INR 2.05
20/04/24: Alb 2.8, Crea 1.6, Calcio 10.8, PCR 17.3, ELP 142/3.2/111, Leuco 7.800, Hb 10.2, Hcto 30.5, Plaquetas 173.000, INR 3.13.
18/04/24: glic 208 Alb 3.9 PCR <5.0 GB 8100 Hb 11.9 Plt 226 mil crea 1.8 VFG 27 ml/min ELP 138/3.0/102 Ca(c) 13.3(ayer 17)

OBSERVACIONES:

HODOM Control INR + ELP para reajuste domingo 28/04/24, evaluar niveles de K sérico.
Control en 15 dias en Policlinico Anticoagulante (TACO)
Control en 15 días en CAE Endocrinología HSC

Control en: 15 días en HOSPITAL DE SAN CARLOS

DANIELA VASQUEZ BAHAMONDEZ
MEDICO TRATANTE
16516335-4

JEFE SERVICIO